

TEMA 6.9 • INFECTOLOGÍA

Ántrax o Carbunco

PERFIL EUNACOM 1.05.1.009

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Ántrax por Bacillus anthracis

Agente: *Bacillus anthracis* (bacilo Gram positivo — uno de los pocos más importantes). **Epidemiología en Chile:** Zona austral, exposición a ganadería de ovejas o vacas. La vacunación del ganado es la medida preventiva clave.

Formas Clínicas

TABLA 6.9.1: FORMA VS CLÍNICA		
FORMA	CLÍNICA	GRAVEDAD
Cutánea (Pústula Maligna)	Vesículas/pústulas agrupadas → úlcera negra, indolora .	Moderada, tratable
Pulmonar / Respiratoria	Neumonía con mediastino ensanchado (adenopatías mediastínicas) + derrame pleural .	Muy grave
Gastrointestinal	Dolor abdominal, diarrea. Clínica inespecífica.	Grave pero rara

Diagnóstico

- **Gram/Cultivo** del exudado → bacilo Gram positivo en cadenas - **PCR** (más sensible/específico) - Serología (anticuerpos)

Tratamiento

TABLA 6.9.2: FORMA VS TRATAMIENTO	
FORMA	TRATAMIENTO
Cutánea / General	Penicilina G EV

| **Respiratoria** (grave) | **Ciprofloxacino + Clindamicina** (2 fármacos)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Agricultor de 45 años de la zona austral de Chile, con antecedente de contacto con ovejas, consulta por una lesión en el antebrazo que inició como vesículas agrupadas y evolucionó a una úlcera de color negro, indolora. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Ántrax o Carbunco. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Ántrax infeccioso es causado por *Bacillus anthracis*, asociado a exposición a animales (alpacas, ovejas). La vacunación del ganado es la medida preventiva más importante.
- Forma respiratoria: la más grave, neumonía con mediastino ancho (adenopatías) y derrame pleural asociado.
- Forma cutánea (pústula maligna): la más preguntable, vesículas/pústulas agrupadas que evolucionan a úlcera negra indolora.
- Forma gastrointestinal: clínica inespecífica (dolor abdominal, diarrea), poco preguntable.
- Diagnóstico: Gram (bacilo grampositivo), cultivo, serología o PCR (más específica).
- Tratamiento: penicilina endovenosa; en forma respiratoria ciprofloxacino + clindamicina.
- En Chile se presenta en la zona austral por ganadería ovina.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ÁNTRAX O CARBUNCO)

PREGUNTA 1

Agricultor de 45 años de la zona austral de Chile, con antecedente de contacto con ovejas, consulta por una lesión en el antebrazo que inició como vesículas agrupadas y evolucionó a una úlcera de color negro, indolora. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Melanoma maligno
- ☐ B) Ántrax cutáneo (pústula maligna)
- ☐ C) Erisipela complicada
- ☐ D) Chancro sifilítico
- ☐ E) Picadura de araña de rincón

PREGUNTA 2

Respecto al ántrax por *Bacillus anthracis*, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- ☐ A) La forma gastrointestinal es la más grave
- ☐ B) *Bacillus anthracis* es un bacilo gramnegativo
- ☐ C) La forma respiratoria se caracteriza por mediastino ancho y derrame pleural
- ☐ D) El tratamiento de todas las formas es exclusivamente con ciprofloxacino
- ☐ E) La forma cutánea se caracteriza por úlceras muy dolorosas

PREGUNTA 3

¿Cuál es la medida preventiva más importante para el ántrax por *Bacillus anthracis*?

- ☐ A) Vacunación de la población expuesta
- ☐ B) Uso de antibióticos profilácticos en trabajadores agrícolas
- ☐ C) Vacunación del ganado (ovejas, alpacas)
- ☐ D) Aislamiento respiratorio de los pacientes infectados
- ☐ E) Desratización de las zonas rurales

RESUMEN: ÁNTRAX O CARBUNCO

Esta clase aborda el ántrax infeccioso causado por *Bacillus anthracis*, no el ántrax estafilocócico. Se asocia a exposición a animales como alpacas y ovejas, siendo la vacunación del ganado la medida preventiva más importante. En Chile se presenta especialmente en la zona austral por la ganadería ovina. Existen tres formas clínicas: la respiratoria, que es la más grave y se presenta como una neumonía con mediastino ancho por adenopatías y derrame pleural asociado; la cutánea, la más preguntable, que se manifiesta con vesículas o pústulas agrupadas que evolucionan a una úlcera negra habitualmente indolora (pústula maligna); y la gastrointestinal, con clínica inespecífica de dolor abdominal y diarrea. El diagnóstico se realiza con tinción de Gram, donde *Bacillus anthracis* es uno de los pocos bacilos grampositivos, complementado con cultivo, serología o PCR, siendo esta última más específica. El tratamiento es con penicilina endovenosa, excepto en la forma respiratoria donde se usa ciprofloxacino más clindamicina.